

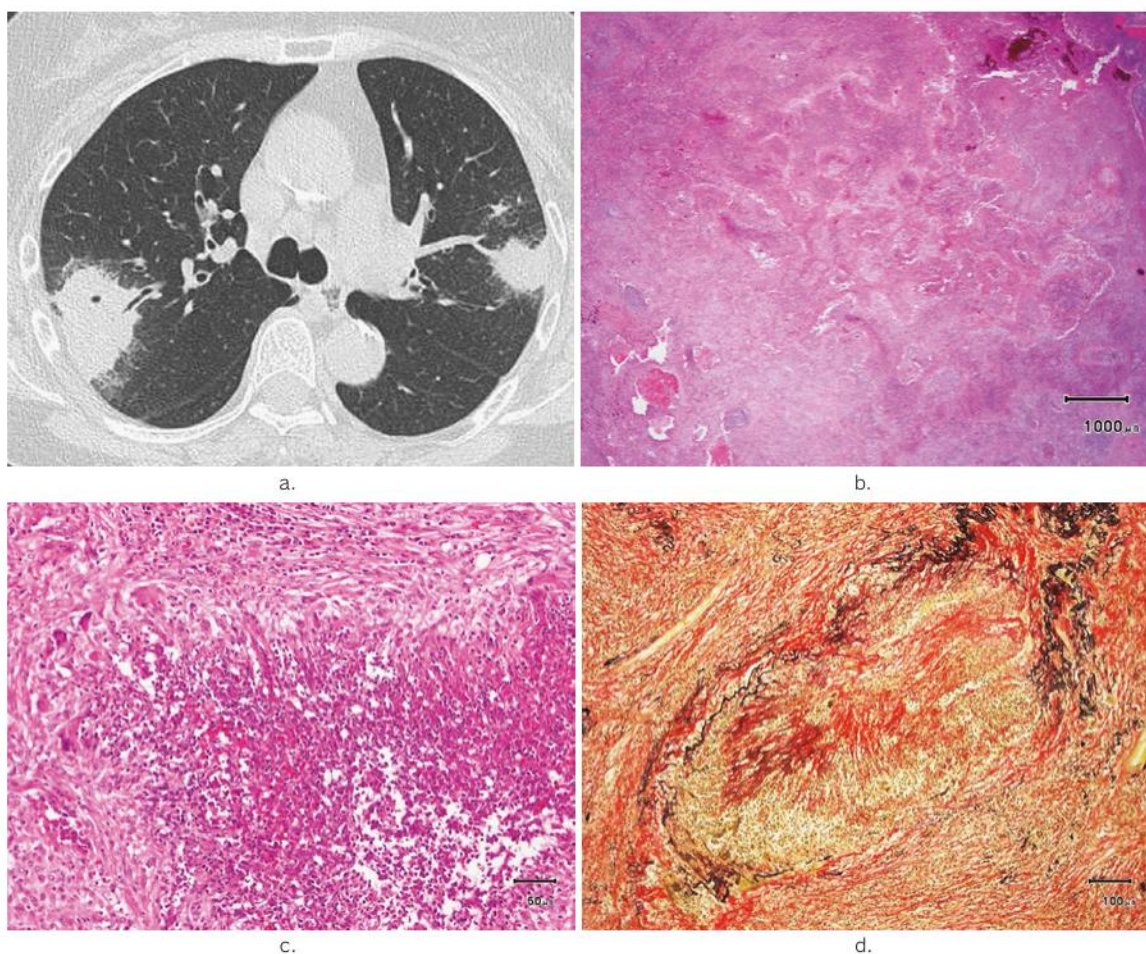


図1 GPA症例

a: 胸部 CT 画像。空洞を有する多発性の腫瘍を認める。
 b: 肺内に大小不同の壊死（好中球壊死）からなる不整壊死病変（地図状壊死）がみられる（HE 染色，scale bar=1 cm）。
 c: 壊死を柵状に取り囲む組織球（palisading granuloma），多核巨細胞を認める（HE 染色，scale bar=50 μm）。
 d: 肺内の細静脈はほとんど内腔が膠原線維で閉塞され，好中球および多核巨細胞の浸潤により血管壁の弾性線維の断裂を認める（EVG 染色，scale bar=100 μm）。

iii) 病理組織学的所見

- ①鼻腔，副鼻腔などの上気道病変では，壊死性血管炎と多核巨細胞を伴う壊死性肉芽腫がみられ早期診断に有用とされているが，典型的な病理組織像を呈さない症例も多い。
- ②肺では地図状の壊死性病変と多核巨細胞を伴う肉芽腫性病変を認める（図1b）。
- ③palisading granuloma：中心部の壊死，好中球集簇に向かうように組織球と巨細胞が取り囲む。組織球は互いに核の長軸方向に平行，かつ中心壊死に対して直角に凝集し palisading histiocyte と呼ばれる。palisading granuloma は GPA に特異性の高い病変で，診断に大変重要である（図1c）。
- ④動静脈の壊死性血管炎をみることもあるが，診断に必須ではない（図1d）。
- ⑤その他，微小膿瘍，壊死性細気管支炎，肉芽腫性細

気管支炎，胸膜炎，器質化肺炎，好酸球浸潤，肺出血なども認められる。

b EGPA

i) 血液検査

末梢血好酸球増多および赤沈亢進が特徴的である。免疫グロブリンの IgE 上昇を伴うことがある。MPO-ANCA は約 70% が陽性となると報告されている。

ii) 胸部画像所見

多彩な画像所見を有するが，一般に多発性の consolidation，すりガラス陰影，小葉中心性粒状陰影，気道壁や小葉間隔壁の肥厚などを認める（図2a）。

iii) 病理組織学的所見

- ①周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細小血管の肉芽腫またはフィブリノイド壊死性血管炎の存在（図2b, c）。
- ②血管外肉芽腫の存在。